HORMONE · TESTOSTERON

TESTOSTERON. MEHR ALS MUSKELN.

Ein lebenswichtiges Sexualhormon – wichtig für Muskeln, Knochen, Blutbildung, Fruchtbarkeit und das allgemeine Wohlbefinden.

BEI MÄNNERN
HAUPTSÄCHLICH IN DEN HODEN

BEI FRAUEN · IN GERINGEREN MENGEN
EIERSTÖCKE & NEBENNIEREN

DIE 7 WICHTIGSTEN AUFGABEN

		WIRKUNG IM KÖRPER
01	MUSKELN & KRAFT	Fördert Muskelproteinsynthese, Muskelmasse und Kraft
02	KNOCHEN	Unterstützt Knochendichte und Knochenstabilität
03	BLUTBILDUNG	Fördert die Produktion roter Blutkörperchen
04	SEXUALITÄT	Unterstützt Libido und normale Sexualfunktion
05	PSYCHE & ENERGIE	Beeinflusst Stimmung, Antrieb und Wohlbefinden
06	FRUCHTBARKEIT	Gemeinsam mit anderen Hormonen nötig für die Spermienproduktion
07	KÖRPERZUSAMMENSETZUNG	Beeinflusst Muskelmasse und Fettverteilung

ZU WENIG? ZU VIEL?

Was ein Mangel bewirkt – und warum mehr Testosteron nicht automatisch mehr Leistung bedeutet.

WAS PASSIERT BEI MANGEL?

MÖGLICHE BESCHWERDEN

LIBIDO ↓
Weniger Verlangen, seltener morgendliche Erektionen

MUSKELN ↓
Verlust von Muskelmasse und Kraft

ENERGIE ↓
Müdigkeit und verminderter Antrieb

KÖRPERFETT ↑
Zunahme des Körperfettanteils

KNOCHEN ↓
Verringerte Knochendichte

STIMMUNG & BLUT
Unter Umständen depressive Verstimmungen und Blutarmut

Diese Beschwerden können auch andere Ursachen haben. Ein Mangel wird deshalb **nicht allein anhand der Symptome** festgestellt.

MEHR TESTOSTERON = MEHR LEISTUNG?

NEIN.

ZU WENIG
Kann Gesundheit, Sexualfunktion und körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

NORMAL
Unterstützt die normalen Körperfunktionen.

ZU VIEL
Kann den Muskelaufbau steigern, erhöht aber Risiken: höherer Hämatokrit, Akne, verminderte Fruchtbarkeit.

Entscheidend ist, ob ein Mangel besteht.

DAS ZIEL EINER TRT

Nicht möglichst viel Testosteron im Körper – sondern ein medizinisch angemessener, physiologischer Spiegel. Und vor allem: Nebenwirkungen vermeiden.

EIN WIRKSTOFF. FÜNF FORMEN.

Der Wirkstoff ist immer Testosteron. Die Unterschiede liegen in Wirkdauer, Freisetzung ins Blut und Anwendungshäufigkeit.

PRÄPARAT	TYPISCHE ANWENDUNG	BESONDERHEIT IN DER PRAXIS
ENANTAT	**ALLE 1-2 WOCHEN** Injektion	Mittellang wirksam, gut dosierbar – bewährter Mittelweg zwischen Wirkdauer und Anpassbarkeit. Spiegel können zwischen den Injektionen schwanken.
CYPIONAT	**ALLE 1-2 WOCHEN** Injektion	Enantat sehr ähnlich, tendenziell etwas längere Halbwertszeit. Klinisch meist kaum relevante Unterschiede.
PROPIONAT	**ALLE 2-3 TAGE** Injektion	Schnelle Freisetzung, sehr kurze Wirkdauer – dafür deutlich häufigere Injektionen.
UNDECANOAT	**ALLE 10-14 WOCHEN** Injektion (Depot)	Sehr lange Wirkdauer, vergleichsweise stabile Spiegel, wenige Injektionen. Nachteil: Bei Nebenwirkungen lässt sich die Wirkung nur langsam beenden.
GEL	**TÄGLICH** auf die Haut	Keine Spritzen, relativ gleichmäßige Spiegel, einfache Dosisanpassung. Nachteil: tägliches Auftragen, schwankende Hautaufnahme, Übertragung auf andere durch Hautkontakt möglich.

WAS IST BESSER?

ES KOMMT AUF DEINE PRIORITÄT AN

FLEXIBILITÄT	SELTEN SPRITZEN	KEINE SPRITZEN	SCHNELL ABSETZEN
ENANTAT ODER CYPIONAT	**UNDECANOAT**	**GEL**	**PROPIONAT ODER GEL**

WICHTIG

Keine Variante ist grundsätzlich stärker oder muskelaufbauender – entscheidend sind die tatsächlich erreichten Spiegel. Alle können die körpereigene Testosteronproduktion und Spermienbildung unterdrücken und den Hämatokrit erhöhen.

Intervalle sind typische Orientierungswerte für eine medizinische TRT, keine individuelle Dosierungsempfehlung. Bei Undecanoat ist die langwirksame Injektionsform gemeint. Grundlage: EAU-Leitlinien (uroweb.org).